

Modelo: 111782204

H371019367A0F
WD86098847A5F

MACOMPANHAMENTO () CONSULTA
NS J3526739516A0

LUIS FERNANDO PAGOTTO

IDADE: 66 PESO: 103 ALTURA: 172 PROFISSÃO: gerente de pessoas
SINTOMAS: Refluxo gastr. / Aposent.
QUEIXAS: Sonolência / Dificuldade p/ iniciar sono / MM II edematosa
MEDICAMENTOS: Lisartana / cotarona / Amlodipino (DLE) do.
Sertoralina / Polivitamínicos / Rilexabarra (anticoag.)
MÉDICO: Dr. André / Dr. Vagner Pegoraro
MARCAPASSO: () SIM () NÃO / COMPANHEIRO(A) USA MARCAPASSO: () SIM () NÃO

EXERCÍCIO FÍSICO: não faz
HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: 5 ALMOÇO: 5 LANCHE: 5 JANTAR: 5 (20h)
HORA QUE DORME: 22:30 HORA QUE ACORDA: 5:30 - 7:30
COCHILLO (X) SIM () NÃO 2h DORME ACOMPANHADO (X) SIM () NÃO () EVENTUAL

BEBIDA ALCOÓLICA (X) SIM () NÃO NA SEMANA () NÃO esposa roroco
FUMO () SIM () NÃO / DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO: de hora em hora
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: 90cm CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO: 40.4.
OVERLAP: não MALLAMPATI: IV (+) IAH: 75.3 e/ev SPO2: 60%.

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: Hernia de hiato
CIRURGIAS: (S) NASAL () AMIGDALECTOMIA (X) Devio Septo / turbinectomia
HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: IMC: 39.14

COMORBIDADE: () RESPIRATÓRIA () ENDÓCRINA () CARDÍACA
() ORTOPÉDICA () NEUROLÓGICA () OUTROS Ombro d/ dor.
24/07 PSG c/ CPAP - 53.7 e/ev - 64% - 36.2 e/ev

24 Avaliação ele já estava ciente sobre a gravidade do caso e a importância do BIPAP

29/07 P = 12 x 7.5 Relato estar sonolento,
24 vazamentos: 48 lpm mas dorme melhor c/
IAH = 2.0 e/ev o CPAP.
Fuga = 48.8 lpm. free.
↓ a pressão 11 x 6 cmH₂O

12/08 P = 12 x 7 cmH₂O } SpO₂ = 87.5% média
24 AHI = 6.5 e/ev } SpO₂ mínima = 70%
m. de uso: 5h20'

02/09/24 P = 12 x 6 modo ST } SpO₂: 88% média
FR: 14 } SpO₂: 70% mínima
→ AHI: 12 e/ev
m. uso: 5h16' * Altero modo *
fuga: 39 l/min. (S) 12 x 7 sílva

16/09/24 P = 12 x 7 modo (S) } SpO₂: 98.7% média refere sentir
→ AHI: 9.9 } SpO₂: 70% mín melhor
m. uso: 5h18' } SpO₂: 97% max na dormi
fuga: * hoco por

BIPAP Resmed *

(vai para sílva
black)

30/09 P = 12 x 7 cmH₂O Resmed
24 AHI: 72.8 e/ev
m. de uso: 5:55'
Fuga 17.4 lpm (média)

Deixo no Bipap
Auto
13 x 8 cmH₂O - free

21/10
2024

Bipap 14x8 cmH₂O
IAH = 66 e/ev
m. de uso = 4h15
fuga = 9l/min

não usou direito
vai fazer Abacof dia 24/10
outras mas bipap toda a dia até o
procedimento / então zero álcool
veja SpO₂ 92% ~ 93%
Silvia

28/10
24

P = 14x8 cmH₂O BIPAP
7 d. utilizou Gd.
m. de uso: 5h26'
fuga = 13.8 lpm
IAH = 46.5 e/ev

Parou 3 d. o álcool.
mas não zerou o álcool.

10/11
24

P = 15x10 cmH₂O
IAH = 6.1 e/ev
m. de uso: 7h5'
fuga = 0,0

Relata que ↓ a ingestão
de álcool
fua

02/12
24

P = 15x10 cmH₂O
IAH = 5.6 e/ev
m. de uso =
fuga = 5h26'

- Relata ↓ de ingestão álcool;
- está escapando ar;
fua cláudia

20/01
25

P = 15x10 cmH₂O
IAH = 6.0 e/ev
fuga = 16"

PA inicial → 7.0 cmH₂O.

relata pouco ar, ↑ a pressão inicial — fua.

24/03
25

P = 15x10 cmH₂O
IAH = 12.8 e/ev
Fuga = 5'
m. de uso: 5h.30'

Iniciou medicação p/ parar
de tomar.

fua cláudia

26/05
25

P = 15x10 cmH₂O
IAH = 10.6 e/ev
Fuga = 15"
m. de uso: 6h36'

30 d. usou 29d

trou o fixador
cefálico.

fua cláudia

Nome: LUIS FERNANDO PAGOTTO
Data de Nascimento: 11-10-1987
IMC: 34.14
Sexo: Masculino
Data do exame:

Nome: LUIS FERNANDO PAGOTTO

Data de Nascimento: 11-10-1957

IMC: 34,14

Sexo: Masculino

Data do exame: 16-06-2024

Peso: 101 kg

Altura: 1,72 m

Médico: DR. ANDRÉ PEREIRA COSTA

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia para titulação de CPAP

Exame realizado na noite de 16-06-2024, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 523,5 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 28,0 e 128,5 minutos. O tempo total de sono foi de 401,0 min, eficiência de 76,6% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,7%; estágio N2: 58,1%; estágio N3: 10,7%; sono REM: 28,4%. O índice de despertares foi de 36,2/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 53,7/hora, sendo 215 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 144 hipopnéias. A SpO2 média foi de 86% e a mínima de 64%, permanecendo 79,6% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 58 - 107 bpm e NREM de 44 - 122 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (14), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM e do estágio N2 do sono NREM aumentada e porcentagem do estágio N3 do sono NREM diminuída;
3. latência para o sono REM aumentada;
4. aumento do número de despertares breves;
5. presença de atividade em EMG de queixo;
6. aumento do número de movimentos periódicos de membros inferiores (40,4/hora);
7. registro de ronco durante o sono.

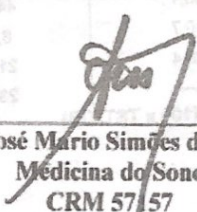
Exame polissonográfico para titulação de CPAP com melhor pressão terapêutica de 13,0 cmH2O.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

Descrição do Exame Polissonográfico

Nome: LUIS FERNANDO PAGOTTO			
Sexo: M	Idade: 66 anos	Peso: 98 Kg	Altura: 1,72 m
IMC: 33,1	Data do Exame: 15/03/2024	Exame: 13300_01	

COMENTÁRIOS:

Exame iniciado às 22:40:44 horas e encerrado às 03:34:57 horas, com latência para o sono de 16 minutos e latência para o sono REM de 76 minutos. O tempo total de sono foi de 202,0 minutos, com eficiência do sono de 68,6%. A distribuição dos estágios do sono mostrou:

Estágio do sono	% encontrada	% prevista *
Estágio 1	11,1%	Até 5%
Estágio 2	63,6%	45 - 55%
Estágio 3	0,0%	> 15%
Sono REM	25,2%	20 - 25%
Eficiência do sono	68,6%	> 85%

No tempo acordado após o início do sono – WASO 76,5 minutos ocorreram **248 despertares (índice de 73,7 /hora)**.

Durante o registro, a frequência cardíaca média foi de 63 bpm , a maior de 75 bpm e a menor de 50 bpm.

Foram identificados **0,0 movimentos periódicos de membros inferiores/hora, e 0,0/hora associados a despertares.**

Ocorreram 277 eventos respiratórios, sendo 0 central e 277 obstrutivos. Sendo 248 apnéias, 29 hipopnéias e 0 RERAS. O **Índice de Distúrbios Respiratórios (IDR) total foi de 82,3/hora**, sendo 73,7 apnéia/hora e 8,6 hipopnéia/hora e 0,0 RERAS/hora. A duração média dos eventos respiratórios foi de 20,8 e a duração máxima de 51,3.

O índice de apnéia/hipopnéia no sono REM foi 75,3/hora, sendo 69,4 apnéia/hora e 5,9 hipopnéia/hora. O índice de RERA no sono REM foi de 0,0. Ocorreram 0 RERAS com tempo médio de 0,0 segundos, com duração máxima de 0,0 segundos.

A **saturação basal da oxihemoglobina** foi de **95%**, sendo a saturação média de **88%**, a maior de **99%** e a mínima de **60%**, permanecendo 116,3 minutos (39,5%) de registro com a saturação abaixo de 90% e 16,9 minutos (5,7%) com a saturação abaixo de 80%. Ocorreram 275 dessaturações. Índice de dessaturações: 81,7/hora. Índice de dessaturações no sono REM: 86,0/hora. Índice de dessaturações no sono Não REM: 80,0/hora.

Resumo dos resultados

- 1 - Índice de Apnéia-Hipopnéia de grau acentuado (normal até 5/hora). Todos os eventos foram do tipo obstrutivo.
- 2 - Dessaturações da Oxihemoglobina.
- 3 - Registro de ronco.
- 4 - Sono fragmentado pelo aumento no número de despertares breves (normal até 10/hora).
- 5 - Eficiência do sono diminuída.

Rosemeiry Terça Marçal
Otorrinolaringologia /
Distúrbios Respiratórios do Sono
CRM-SP 71200



Paciente:

LUIS FERNANDO PAGOTTO

CPF do Paciente:
004.892.378-86

Nascimento:
11/10/1957

Emissão:
02/07/2024 - 10:50:47

Endereço:

RUA MARIANA - 263, BOSQUE DOS EUCALIPTOS - 12233220, SAO JOSE
DOS CAMPOS - SP

Campo exclusivo ao laboratório
Documento assinado digitalmente via Mevo.

Para confirmar a validade da assinatura, acesse

<https://validar.iti.gov.br/>



Código da solicitação:
MDRTJ3V

Código de acesso:
9969

CONTRATO DE

1. DADOS DA LOCADORA
NOME: Faria e Matos Comércio de Equipamento

CNPJ:

13.181.386/0001-27

ENDERECO:

Rua Santa Elza, 419

CEP:

12243-690

2. DADOS DO

NOME:

Solicitação de Exames

POLISSONOGRAMA COM TESTE DE CPAP/BIPAP NASAL

CID: **G47.3**- Apnéia de sono

Indicação clínica:

paciente com apnéia severa com melhora parcial com cpap
solicito teste com bipap.



ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO DIGITALMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL PADRÃO
ICP-BRASIL AMPARADO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 2200-2/2001

Dr(a). **ANDRE PEREIRA COSTA** | CRM 144324 SP

RUA DOLZANI RICARDO 620 CENTRO - SAO JOSE DOS CAMPOS SP - CEP 12210110 Telefone: (12) 3876-1999

Paciente, acesse sua receita digital em <https://r.mevosauade.com.br/MDRTJ3V>

Luiz Fernando Boer

Do Otorrino

Análise de Apneia do

Sono grave para
uso de CPAP.

Resposta Filmação das
que é Ricardo/Preçatada pela
apneia do sono

24/05/14

Wagner R. Pegoraro
Médico Otorrinolaringologista